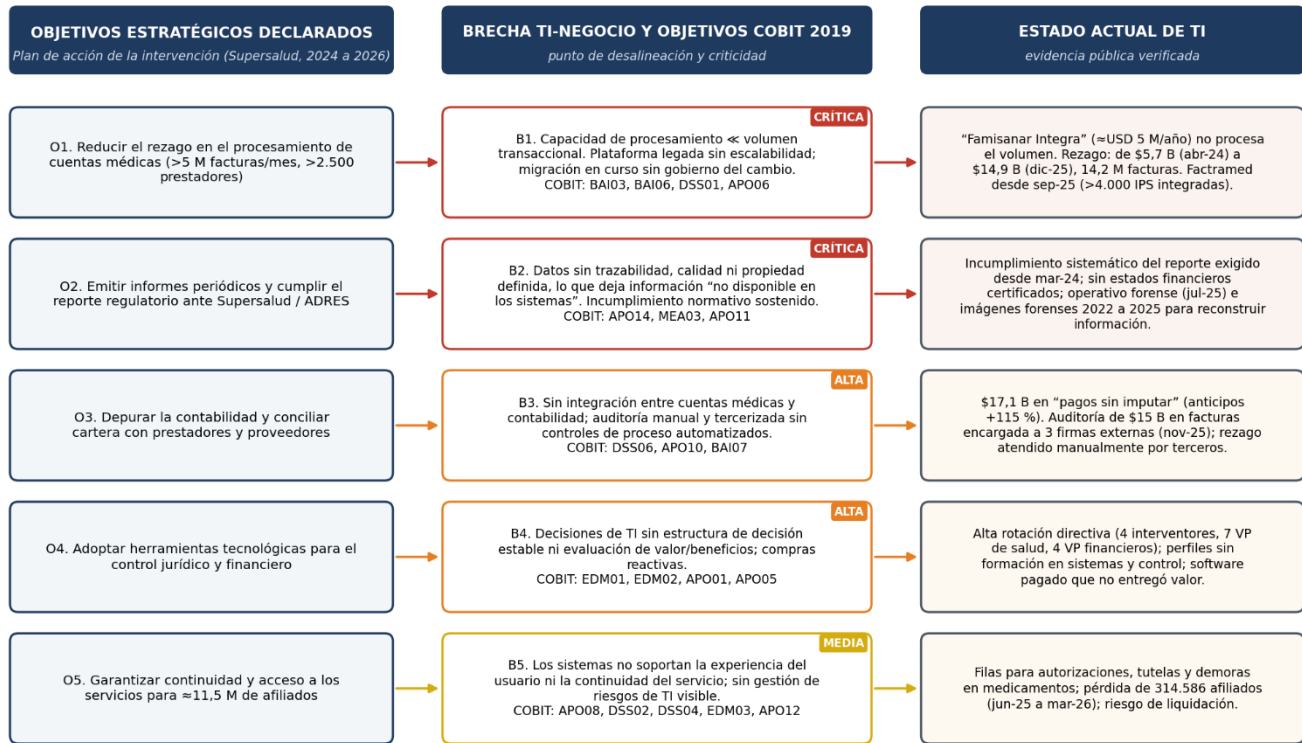


BITÁCORA DE GOBIERNO #1
Mapa de brechas TI-negocio
Gerencia y Gobierno de TI – Unidad 1 Actividad 2
Caso: Nueva EPS S.A.

Campo Ariza, Felix Mauricio – Toledo Lugo, Pablo Andrés

Propósito y alcance. Primera exploración estructurada de Nueva EPS para contrastar los objetivos estratégicos declarados en el plan de acción de la intervención con el estado actual de sus tecnologías de información, identificar los puntos de desalineación más críticos y formular hipótesis sobre los mecanismos de gobierno ausentes. El análisis se acota al proceso de cuentas médicas y reporte regulatorio (radicación -> auditoría -> contabilización -> conciliación/pago -> reporte), definido en el Canvas como núcleo del reto de gobierno.

1. MAPA VISUAL DE BRECHAS TI-NEGOCIO (COBIT 2019)



Criticidad de la brecha (impacto sobre el negocio x urgencia): ■ Crítica ■ Alta ■ Media

Cadena de valor afectada: radicación -> auditoría de cuentas -> contabilización -> conciliación/pago -> reporte regulatorio.

B1 y B2 constituyen la causa raíz técnica; B3, B4 y B5 son sus efectos, amplificadas por la ausencia de estructuras de gobierno (B4). Elaboración propia con base en COBIT 2019 (ISACA). Bitácora #1, caso Nueva EPS

Lectura del mapa. Las cinco brechas comparten un patrón: la organización declara objetivos que dependen de información oportuna y confiable, pero sus sistemas y datos no pueden producirla. B1 y B2 son las brechas raíz (capacidad de procesamiento y gobierno de datos); B3 y B5 son sus consecuencias operativas y sobre el usuario; B4 explica por qué las brechas raíz persistieron durante dos años de intervención: no hubo una estructura estable que gobernara las decisiones de TI.

2. DIMENSIONES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL AFECTADAS (≥3, CON EVIDENCIA)

Dimensión de TD	Evidencia concreta	Fuente	Brecha
Infraestructura tecnológica sistemas	Plataforma "Famisanar Integra" (≈USD 5 M/año) incapaz de procesar ≈5 M facturas/mes; rezago de \$5,7 B (abr-24) a \$14,9 B (dic-25); migración a Factramed desde sep-25 con >4.000 IPS integradas y ciclo completo radicación→contabilidad.	Razón Pública (sep-25); ConsultorSalud (jul/sep-25, abr-26); Supersalud, Res. 2026100000003814-6	B1, B3
Gestión de datos	Incumplimiento sistemático del reporte de información exigido desde mar-24; carencia de estados financieros certificados; operativo de recolección de información "no disponible en los sistemas" con imágenes forenses 2022–2025.	Supersalud (Res. abr-26; concepto técnico 27-feb-26); Semana (sep-25)	B2
Procesos	Auditoría de cuentas médicas manual y tercerizada (3 firmas para \$15 B en facturas, nov-25); \$17,1 B en pagos sin imputar a facturas; sin conciliación efectiva con prestadores.	El Tiempo (nov-25); ConsultorSalud (sep-25); Supersalud	B3
Estrategia	Decisiones tecnológicas reactivas: continuidad de un sistema que no entrega valor, contratación de reemplazo sólo tras 17 meses de intervención; plan de acción ordena "adopción de herramientas tecnológicas" sin PETI público.	Infobae (abr-26); Razón Pública (sep-25)	B4
Cultura organizacional	4 interventores, 7 VP de salud y 4 VP financieros desde abr-24; perfiles directivos sin formación en sistemas de información y control; disputas Supersalud–Procuraduría por el procedimiento de intervención.	Razón Pública (sep-25); ConsultorSalud (abr-26)	B4
Experiencia del cliente	Filas para autorizaciones y trámites, tutelas, demoras en medicamentos; pérdida neta de 314.586 afiliados entre jun-25 y mar-26 (–2,7 %).	Portafolio (abr-26); Semana (abr-26)	B5

3. ANÁLISIS PRELIMINAR DE CAUSAS E HIPÓTESIS SOBRE MECANISMOS DE GOBIERNO

Brecha	Causa preliminar (¿por qué existe?)	Hipótesis: mecanismo de gobierno ausente o deficiente	Tipo de falla		Referente
B1	Se mantuvo por años una plataforma sin capacidad para el volumen; la sustitución se decidió tarde y bajo presión, sin gestión del cambio.	H1. No existe gestión de portafolio ni evaluación de beneficios de las inversiones de TI (se paga por software que no entrega valor sin mecanismo que lo detecte). H2. La migración a Factramed carece de un proceso formal de gestión del cambio y transición (riesgo de repetir el rezago).	Recursos gestionados; ausencia de proceso	mal de	COBIT EDM02, APO05, BAI06/BAI07; ITIL 4 (cambio)
B2	Nadie es “dueño” de los datos de cuentas médicas; sin catálogo, reglas de calidad ni trazabilidad de la factura desde radicación hasta pago.	H3. Ausencia de política y estructura de gobierno de datos (data owners, calidad, linaje). H4. El monitoreo del cumplimiento regulatorio (reportes Supersalud/ADRES) no está integrado como proceso; se atiende de forma reactiva.	Ausencia de políticas; incumplimiento normativo	de	COBIT APO14, MEA03; Circular Única Supersalud; Res. 2275/2023 y 948/2026 (RIPS-FEV)
B3	Cuentas médicas y contabilidad operan como silos; los terceros auditan sin SLAs ni controles automatizados de integridad.	H5. Gestión deficiente de proveedores y servicios tercerizados (sin acuerdos de nivel de servicio, sin controles de proceso de negocio embebidos en los sistemas).	Recursos gestionados	mal	COBIT APO10, DSS06; ITIL 4 (gestión de proveedores)
B4	La rotación directiva impide sostener decisiones de TI; no hay CIO con autoridad ni comité que arbitre prioridades de inversión.	H6. No existe una estructura de decisión de TI estable (comité de gobierno de TI / arquetipo de decisión claro, Weill & Ross) que sobreviva a los cambios de interventor.	Falta de estructuras de decisión	de	COBIT EDM01, APO01; MGGTI-MinTIC (esquema de gobierno de TI)
B5	El diseño de los sistemas privilegia el trámite administrativo sobre el acceso; no hay gestión visible de riesgos de TI ni de continuidad.	H7. Ausencia de gestión de riesgos de TI (EDM03/APO12) y de continuidad del servicio; si se introduce analítica/IA para priorizar auditoría de cuentas, no hay marco que gobierne su riesgo.	Ausencia de políticas; riesgo	de	COBIT EDM03, APO12, DSS04; NIST AI RMF 1.0

Las hipótesis H1–H7 orientarán la selección del marco en la Unidad 2: COBIT 2019 como columna vertebral (EDM/APO/BAI/DSS/MEA), ITIL 4 para la gestión del servicio y de proveedores, y NIST AI RMF para gobernar el componente analítico del proyecto.

4. REGISTRO REFLEXIVO DEL EQUIPO

Supuestos asumidos	Fuentes consultadas	Incertidumbres y preguntas abiertas
- Una parte sustantiva del rezago se explica por capacidad y gobierno de los sistemas, no sólo por falta de liquidez (la Supersalud lo atribuye a “deficiencias en sistemas de información”). - Factramed sigue en operación y es la plataforma objetivo; no hay evidencia pública de su desempeño post-migración. - Los datos abiertos agregados (Supersalud, ADRES, SISPRO/BDUA) son suficientes para la pregunta analítica; no se accederá a microdatos internos. - La prensa sectorial citada refleja fielmente documentos oficiales (resoluciones, conceptos técnicos) que no siempre son de acceso directo.	- Supersalud: Res. 2024160000003012-6 (3-abr-24); Res. 2026100000003814-6 (10-abr-26); concepto técnico Delegada de Aseguramiento (27-feb-26); oficio a Procuraduría (14-abr-26). - Prensa sectorial: ConsultorSalud (jul/sep-25, abr/may-26), El Tiempo (nov-25), Semana (sep-25, abr-26), Infobae (abr-26), Portafolio (abr-26), El Espectador (nov-25), Razón Pública (sep-25). - Marcos: COBIT 2019 (ISACA), ITIL 4, NIST AI RMF 1.0, MRAE/MGGTI (MinTIC), Weill & Ross (2004). - Normativa: Ley 1581/2012; Ley 2015/2020; Res. 2275/2023 y 948/2026; Decreto 780/2016; EOSF art. 116.	- El cambio de Gobierno Nacional (agosto de 2026) podría haber modificado el agente interventor, la dirección de la Supersalud o el plan de acción vigente; el diagnóstico se contrastará con los actos administrativos más recientes. ¿Qué porcentaje del rezago ya migró a Factramed y con qué tasa de procesamiento? ¿Existe informe público de la interventoría? ¿Existen hallazgos técnicos específicos sobre TI (auditoría de sistemas) publicados por la Supersalud o la Contraloría? ¿Qué nivel de desagregación tienen los datos abiertos de cuentas por pagar/facturación para operacionalizar la pregunta analítica?